AutaMedica IA

Historia Clínica Digital con Inteligencia Artificial

CASO CLÍNICO SIMULADO — DEMOSTRACIÓN

Historia Clínica del Paciente

Paciente simulada | 40 años | Femenina **Fecha:** 2026-03-28 | **Motor de extracción:** Desarrollo interno AutaMedica

---

Datos Personales

Campo	Valor
Edad	40 años
Ocupación	Contadora (15 años, trabajo sedentario)
Exposición laboral	Pantalla >10 hs/día, estrés fiscal

Motivo de Consulta

> **Cefalea crónica** — 3 meses de evolución, predominio vespertino

---

Enfermedad Actual

Paciente femenina de 40 años, contadora con alta carga laboral visual, que consulta por cefalea de 3 meses de evolución, de aparición vespertina y predominio en días de semana.

> **SEMIOLOGÍA (ALICIADO 8/8):** La cefalea inició de forma insidiosa hace 3 meses, presentándose casi a diario. Se localiza en la región nucal y se irradia bilateralmente hacia las sienes. El carácter es opresivo. La intensidad habitual es 6-7/10, alcanzando 8/10 en los episodios más severos. Los episodios duran 4-5 horas sin medicación. Se desencadena por exposición prolongada a pantalla y mejora durante los fines de semana. Se atenúa parcialmente con ibuprofeno. Se asocia a fotofobia y náuseas ocasionales en picos de máxima intensidad.

NEGATIVOS PERTINENTES: Niega vómitos y fonofobia. No se interrogaron: cefalea en trueno, cefalea que despierte del sueño, déficit neurológico focal, rigidez de nuca, fiebre, pérdida de peso.

EVOLUCIÓN: Patrón casi diario x 3 meses. Automedicación con ibuprofeno 400mg 2-3x/semana (alivio parcial). Paracetamol con menor efecto.

Parámetro	Detalle
Cronología	3 meses, inicio insidioso
Severidad	6-8/10 EVA
Síntomas asociados	Fotofobia, náuseas ocasionales
Factores agravantes	Pantalla prolongada, estrés laboral
Factores aliviantes	Descanso (fines de semana), ibuprofeno (parcial)
Tratamientos probados	Ibuprofeno 400mg 2-3x/sem, Paracetamol 500mg

CASO CLÍNICO SIMULADO — DEMOSTRACIÓN

Antecedentes

Personales

- **HTA** diagnosticada hace 2 años — Enalapril 10mg/día (adherencia irregular)
- **Alergia Penicilina** — Anafilaxia en infancia (rash, angioedema, disnea)
- G1P1 (Cesárea 2015) — Ciclos regulares

Estilo de vida

- Sedentaria | Café 3-4/día | Alcohol social | No tabaquista | Sueño 6-7hs

Familiares

- Padre: fallecido IAM a los 65 (HTA)
- Madre: viva, 70 años, HTA
- Abuela materna: DBT2

Medicación

Medicamento	Dosis	Frecuencia	Nota
Enalapril	10mg	1x/día	Adherencia irregular
Ibuprofeno	400mg	2-3x/sem	Automedicación
Paracetamol	500mg	Ocasional	Menor eficacia

Revisión por Sistemas

Sistema	Hallazgos
Cardiovascular	Niega palpitaciones, disnea, edemas
Respiratorio	Niega tos, disnea
Digestivo	Acidez asociada a ibuprofeno
Genitourinario	Niega disuria. Ciclos regulares

CASO CLÍNICO SIMULADO — DEMOSTRACIÓN

ANÁLISIS CLÍNICO — AutaMedica IA

Cruces entre secciones (razonamiento integrador)

CRITICAL — Antecedente de reacción anafiláctica a Penicilina. Requiere señalización prominente en toda historia clínica.

HIGH — El consumo de ibuprofeno ocurre 8-12 días/mes durante 3 meses. Este patrón se aproxima al criterio temporal descrito en la literatura para cefalea por uso excesivo de medicación. *Cruce: medicamentos × motivo de consulta*

HIGH — Paciente con HTA y cefalea de reciente comienzo. La adherencia irregular al enalapril podría influir en el control tensional y ser un factor contribuyente. *Cruce: antecedentes personales × motivo de consulta × medicamentos*

MEDIUM — Acidez gástrica asociada específicamente al consumo frecuente de ibuprofeno. *Cruce: medicamentos × digestivo*

MEDIUM — Sedentarismo, alto consumo de cafeína, estrés laboral y exposición a pantallas como factores contribuyentes o desencadenantes. *Cruce: hábitos × filiación × motivo de consulta*

Alertas de seguridad

Alerta	Relevancia
Alergia a Penicilina con anafilaxia	CRÍTICA
Adherencia irregular a Enalapril	ALTA
Uso frecuente de AINEs (2-3x/sem × 3 meses)	ALTA
Padre fallecido por IAM a los 65 años	ALTA

Cobertura semiológica

Cubiertas (6):
Datos personales, Motivo de consulta, Enfermedad actual, Antecedentes personales, Antecedentes familiares, Hábitos

Débiles (2):
Interrogatorio neurológico extendido, Examen físico

Nivel de extracción: R4 (residente avanzado) — ALICIADO 8/8, negativos pertinentes, cruces entre secciones, screening de red flags

Intervenciones IA: 2 checkpoints (parcial paso 6 + final paso 13) con 3 preguntas dirigidas al paciente

Motor: Desarrollo interno AutaMedica | **Score:** 25/28 (89%)

Documento confidencial — Ley 26.529 de Derechos del Paciente

AutaMedica IA — Investigador: E.M. — En fase de validación clínica ampliada